



El Gobierno aprueba el reglamento de accesibilidad cognitiva, Nature Human Behaviour alerta sobre el acoso en el networking académico y una revisión en Papeles del Psicólogo analiza el deterioro cognitivo subjetivo como marcador preclínico de demencia: claves del 17 de septiembre de 2026

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El Gobierno ha aprobado el Reglamento de accesibilidad cognitiva, que entrará en vigor en enero de 2027 y afecta directamente a la atención sanitaria. Nature Human Behaviour publica un artículo de opinión sobre el acoso en contextos de networking académico y su relación con la fuga de talento científico. La EFPA suma a ESPA, asociación europea de psicólogos de lesión medular, como nuevo miembro asociado. Una revisión en Papeles del Psicólogo analiza el deterioro cognitivo subjetivo como posible marcador preclínico de demencia.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

El Gobierno aprueba el reglamento de accesibilidad cognitiva, con obligaciones específicas para la atención sanitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de enero de 2027. Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la norma desarrolla el mandato de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, y constituye, según ha destacado el Ministerio, el primer marco normativo en España que aborda de manera transversal este tipo de accesibilidad. El reglamento se aplica a ámbitos como la sanidad, las Administraciones Públicas, la Justicia, el empleo, los transportes, las telecomunicaciones y los procesos electorales, y establece que la información deberá ofrecerse en formatos comprensibles —lenguaje claro, lectura fácil, pictogramas o apoyos visuales y sonoros— sin coste adicional para la persona usuaria y sin retrasos indebidos, en particular cuando esté en juego el ejercicio de un derecho o una situación de emergencia. En el ámbito sanitario, las personas podrán solicitar que la información sobre tratamientos, intervenciones o medicación se les facilite en un formato adaptado, y los centros deberán habilitar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, con especial atención a los servicios de urgencias. La norma también reconoce el derecho a acudir acompañado de una persona de confianza a cualquier consulta o exploración, salvo en supuestos de riesgo de violencia de género u otras amenazas. Las condiciones tienen carácter de mínimos, por lo que las comunidades autónomas podrán ampliarlas dentro de sus competencias.

Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 / BOE

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Nature Human Behaviour alerta sobre el impacto del acoso en el networking académico en la carrera investigadora

Un artículo de opinión publicado en la sección World View de Nature Human Behaviour alerta sobre el impacto del acoso durante actividades de networking

académico —congresos, reuniones profesionales y colaboraciones— en la trayectoria de las personas investigadoras. Su autora, Shahar Hechtlinger, investigadora del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, en Alemania, sostiene que este tipo de acoso presenta rasgos propios: suele implicar a investigadores visitantes, colaboradores externos o figuras consolidadas del ámbito científico, lo que dificulta tanto la denuncia como la respuesta institucional, ya que las instituciones carecen con frecuencia de mecanismos claros para actuar cuando la persona implicada no pertenece a su plantilla. Según la autora, esta situación obliga a evaluar de forma constante el riesgo asociado a asistir a determinadas reuniones o eventos, un esfuerzo invisible que no queda reflejado en el currículum pero que puede acumularse a lo largo de la carrera. El artículo vincula este fenómeno con la denominada fuga de talento (leaky pipeline), que describe la salida progresiva de mujeres y otros grupos infrarrepresentados de la carrera científica, y señala que la literatura sobre este fenómeno se ha centrado en factores como la contratación, la promoción o la conciliación, sin prestar apenas atención a la vulnerabilidad que genera el propio networking. Como respuesta, propone que los congresos cuenten con equipos de sensibilización, políticas claras desde el inicio de los eventos y mecanismos accesibles para comunicar incidentes, así como directrices institucionales para gestionar denuncias que impliquen a investigadores externos.

Fuente: Nature Human Behaviour

CLÍNICA · INTERNACIONAL

La EFPA suma a ESPA, asociación europea de psicólogos de lesión medular, como nuevo miembro asociado

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) ha anunciado la incorporación de la Asociación Europea de Psicólogos de Lesión Medular (European Spinal Psychologists Association, ESPA) como nuevo miembro asociado. La admisión fue aprobada durante la Asamblea General Ordinaria de la EFPA, celebrada en junio de 2026. ESPA reúne a psicólogos y psicólogas que trabajan en el ámbito de la lesión medular y promueve el intercambio de conocimientos y la práctica clínica en Psicología Clínica y Psicología de la Salud, así como estándares asistenciales elevados y la colaboración en

investigación dentro de su ámbito de actuación. Con esta incorporación, ESPA pasa a formar parte de la red europea de organizaciones vinculadas a la EFPA como miembro asociado. La EFPA ha dado la bienvenida a la organización y ha señalado que espera trabajar conjuntamente para avanzar en objetivos compartidos dentro de la Psicología europea.

Fuente: Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA)

Publicaciones científicas recientes

Pérez, V., Batallas, D., Hidalgo, V., y Salvador, A. (2026). Deterioro cognitivo subjetivo como marcador preclínico de demencia: una revisión teórica y marco conceptual de estudios longitudinales en adultos mayores. *Papeles del Psicólogo/Psychologist Papers*, 47(3), 223–231.

DOI: [10.70478/pap.psicol.2026.47.24](https://doi.org/10.70478/pap.psicol.2026.47.24)

Hallazgo: La revisión, publicada en *Papeles del Psicólogo/Psychologist Papers* por Pérez, Batallas, Hidalgo y Salvador, analiza evidencia longitudinal sobre el deterioro cognitivo subjetivo (DCS) —una disminución percibida y persistente de las capacidades cognitivas, con rendimiento normal en las pruebas estandarizadas de deterioro cognitivo leve (DCL)— como posible marcador preclínico de demencia. Los autores citan una revisión de 32 estudios longitudinales que encontró asociaciones más robustas cuando se consideraban conjuntamente varios síntomas de DCS, y otra revisión con 46 estudios y más de 74.000 participantes que identificó el DCS como factor de riesgo de DCL y enfermedad de Alzheimer. En una cohorte de 873 personas seguida durante seis años, un incremento anual de un punto en el DCS se asoció con un riesgo casi cuatro veces mayor de desarrollar demencia en diez años; en otro estudio, el DCS se produjo 4,4 años antes del DCL, 6,8 años antes de la enfermedad de Alzheimer y 6,9 años antes de la demencia. En un seguimiento de siete años, el 54% de las personas con deterioro de memoria informado por otra persona progresó a DCL o demencia, frente al 22,6% en el grupo sin esta información externa. Un estudio con 14.066 personas mayores de 50 años mostró que tanto la ansiedad como el DCS se asociaron de forma independiente con mayor riesgo de DCL o demencia, con un riesgo aún mayor cuando coexistían ambos factores.

Implicación clínica: A partir de esta evidencia, las autoras proponen un modelo de evaluación integral del DCS en cinco fases —queja cognitiva estandarizada, contraste con persona informante, evaluación neuropsicológica sensible, factores emocionales y sociodemográficos, y biomarcadores complementarios cuando los recursos lo permitan— planteado como guía estructurada y no como protocolo diagnóstico cerrado. Los resultados sugieren que no todas las personas con DCS desarrollarán demencia, aunque existe un subgrupo con mayor riesgo de progresión, por lo que puede resultar relevante valorar la persistencia, intensidad y repercusión funcional de las quejas de memoria, integrando información clínica, neuropsicológica, emocional y social para diferenciar el envejecimiento saludable de un riesgo real de deterioro.

Herramientas clínicas e instrumentos

– Recursos tecnológicos de apoyo a la comunicación cognitivamente accesible:

El nuevo reglamento de accesibilidad cognitiva contempla el uso de recursos tecnológicos genéricos —como el chat en directo o sistemas de inteligencia artificial conversacional— para guiar a las personas con dificultades cognitivas en trámites y procedimientos, de forma escrita, por voz o mediante apoyos visuales, en el entorno sanitario, administrativo y digital.

Prioridades del día

Revisar la accesibilidad de la información clínica que se entrega a pacientes

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento en enero de 2027, puede ser útil explorar si la información sobre tratamientos, consentimientos o pautas de tratamiento que se entrega en consulta podría beneficiarse de un lenguaje más claro o de apoyos visuales, especialmente en la atención a personas mayores, con discapacidad o con dificultades de comprensión.

Incorporar la queja de memoria persistente como parte de la valoración en personas mayores

A la luz de la revisión sobre deterioro cognitivo subjetivo, puede ser relevante incorporar en la evaluación con personas mayores una exploración específica de la persistencia e intensidad de las quejas de memoria, contrastándola cuando sea posible con la información aportada por un familiar o persona cercana.

Establecer protocolos de conducta en la participación en congresos y actividades de networking

De cara a la asistencia a congresos, jornadas o actividades de formación continuada, puede ser oportuno revisar si existen canales claros para comunicar situaciones de acoso o conducta inadecuada, tanto como profesional que participa como, en su caso, como organizadora de actividades formativas.